



ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE S.A.S
NIT. 801000713-9

CENTRO DE ATENCIÓN. CLINICA DE ALTA TECNOLOGIA SEDE ARMENIA
PBX: 7383100 CITA: 7383110

ESTUDIO:	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABDOMEN TOTAL)		
NOMBRE:	HERIBERTO ROJAS NOREÑA		
DOCUMENTO:	CC 7502821	EDAD:	79 AÑOS
FECHA ESTUDIO:	16-01-2026	REMITE:	GUSTAVO ADOLFO TORO MARTINEZ
ENTIDAD:	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	SEDE:	CLINICA DE ALTA TECNOLOGIA SEDE ARMENIA

TOMOGRAFIA DE ABDOMEN Y PELVIS CONTRASTADO

INDICACIÓN: Estudio de control. Antecedente de tumor maligno de próstata. Sin exámenes anteriores para comparar.

TECNICA:

Se realiza estudio en fase contrastada endovenosa, con equipo multidetectores. Cortes axiales, secuenciales con reconstrucciones multiplanares a nivel de abdomen y pelvis.

HALLAZGOS:

El hígado es de forma, tamaño y posición habitual, con disminución difusa de la densidad (grado II/IV) por infiltración grasa y/o hepatopatía de base. Sin aparentes lesiones focales o sospechosas. Realza de manera homogénea con el contraste y sin lesiones vasculares asociadas.

Vía biliar intra y extra-hepática se conserva.

Vesícula biliar distendida, de paredes delgadas y sin lesiones endoluminales.

Páncreas, grandes vasos y retroperitoneo realzan de manera adecuada con el contraste. Ateromatosis y tortuosidad aortoiliaca sin dilataciones aneurismáticas, obstrucciones o aparentes adenopatías regionales.

Riñones que concentran y eliminan adecuadamente el material de contraste determinándose de forma, tamaño y posición usual. Quiste simple dominante polar inferior y lateral derecho hasta de 51 mm de diámetro. Uréteres parcialmente vistos en su recorrido hasta la desembocadura vesical y sin anomalías. Regiones suprarrenales sin lesiones actuales.

Bazo de forma, tamaño y posición usual. Sin lesiones focales o difusas. Realza de manera homogénea con el contraste y sin lesiones vasculares u otros.

Goteras parietocólicas libres.

Vejiga distendida, de paredes engrosadas de 7 a 8 mm y sin lesiones endoluminales.

Próstata y región rectosigmoidea parcialmente evaluada por artificio en relación a cambios operatorios de cadera izquierda.

Los tejidos blandos de la pared abdominal se conservan y con hernia umbilical grasa y milimétrica.

En ventana ósea, la densidad es aceptable y sin imágenes aparentemente sospechosas a este examen. Acuñaamiento y osteocondrosis de la columna lumbosacra, artrosis en la unión e imbalance de caderas. Reemplazo de cadera izquierda con artificio mediano. Artrosis de cadera derecha.

OPINIÓN:

INFILTRACIÓN GRASA Y/O HEPATOPATIA DE BASE A ESTUDIO.

QUISTE SIMPLE RENAL DERECHO.

PROSTATA NO ADECUADAMENTE EVALUADA EN ESTE CONTROL.

OTROS HALLAZGOS NO CLARAMENTE SOSPECHOSOS.

CORRELACIONAR CON ESTUDIOS PREVIOS Y EVALUAR OTROS COMPLEMENTARIOS.

Transcribe: MVO.



Informe firmado electrónicamente por:

GUSTAVO ADOLFO TORO MARTINEZ

Medico Radiologo

No. registro:

Fecha y hora de firma: 21-01-2026 09:21